BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Okul Sağlığı Süreci Çalışma Notu

Risk Değerlendirmesi · Öğrenci Taramaları ve Girişimler · Kronik Hastalığı Olan Öğrenci · Okul Çalışanları · Veli ve Çalışan Eğitimi · Omaha

FR.186 Okul Sağlığı Süreci (26 puan) için: okulda neye bakılır, riskler nasıl puanlanır, taramalar nasıl yapılır, eğitimler nasıl organize edilir ve kaydedilir.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – Okul Sağlığı Süreci Çalışma Notu

1. Okul sağlığı nedir, neden önemlidir?

- 1.1 Okul sağlığı hemşiresinin rolleri
- 1.2 Okul sağlığının bileşenleri
- 1.3 Türkiye'de okul sağlığıyla ilgili bazı uygulamalar

2. OKUL SÜRECİNİ NASIL YÜRÜTÜRSÜN? (GENEL AKIŞ)

3. OKULUN RİSK DEĞERLENDİRMESİ (MADDE 15)

- 3.1 Risk değerlendirmesi nedir?
- 3.2 Risk değerlendirmesinin basamakları
- 3.3 Değerlendirilecek alanlar – neye bakacağım?
- 3.4 Riskin puanlanması (olasılık × şiddet)
- 3.5 Kontrol önlemleri – hangi önlem daha etkili?
- 3.6 Girişim planını yazmak

4. ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA YÖNELİK GİRİŞİMLER (MADDE 16)

- 4.1 Tarama öncesi hazırlık
- 4.2 Okul taramaları – nasıl yapılır?
- 4.3 Tarama sonrası
- 4.4 Öğrencilere sağlık eğitimi ve etkinlikler
- 4.5 Kronik hastalığı olan öğrencinin izlemi
- 4.6 Okulda bulaşıcı hastalıklar

5. OKUL ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER (MADDE 17)

- 5.1 Çalışanların sağlık riskleri
- 5.2 Çalışanlara yönelik taramalar ve kronik hastalık izlemi
- 5.3 Çalışanlara yönelik eğitim konuları

6. EĞİTİMİN UYGULANMASI: VELİ VE ÇALIŞANLARLA İLETİŞİM (MADDE 18)

7. OKULDA OMAHA KULLANIMI (MADDE 19)

8. OKUL SAĞLIĞI SÜRECİ RAPORU NASIL HAZIRLANIR?

9. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – Okul Sağlığı Süreci Çalışma Notu

Bu not, FR.186 Saha Çalışması Değerlendirme Formu'ndaki **"Okul Sağlığı Süreci (26 puan)"** bölümüne hazırlanman için yazıldı. Bu bölümde beş madde puanlanır:

- **Madde 15 (5 puan):** Okulun **risk değerlendirmesini** yapmak ve buna uygun girişim planlamak
- **Madde 16 (6 puan): Öğrenci sağlığına** yönelik girişim yapmak (tarama, sağlık eğitimi, sağlıkla ilgili bir etkinlik planlama, öğrencilerin sağlık risklerini belirleme, kronik hastalığı olan öğrencilerin izlemi vb.) – fotoğrafla kanıtlayarak
- **Madde 17 (6 puan): Okul çalışanlarına** yönelik hemşirelik girişimi yapmak (tarama, sağlık eğitimi, çalışanların sağlık risklerini belirleme, kronik hastalığı olan çalışanların izlemi vb.) – fotoğrafla kanıtlayarak
- **Madde 18 (4 puan):** Uygulama öncesi hazırlanan konuda eğitimin uygulanması (**çalışanlar ve veliler ile iletişimin kurulması, eğitim zamanı ve süresinin belirlenmesi**), eğitim sırasında materyallerin etkin kullanılması ve **eğitimin değerlendirilmesi**
- **Madde 19 (5 puan):** Eğitimlerde **Omaha** sınıflama sistemini kullanma

Profesyonel davranışlar puanı da okul sürecinde ayrıca verilir ve ASM ile toplum süreci puanlarıyla ortalaması alınır.

---

1. Okul sağlığı nedir, neden önemlidir?

Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık sorunlarını erken saptamak, sağlıklı ve güvenli bir okul ortamı oluşturmak ve öğrencilere sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak için yürütülen hizmetlerin bütünüdür.

Okul sağlığının önemi şuradan gelir:

- Okul çağındaki çocuklar ve gençler toplumun büyük bir bölümünü oluşturur ve günlerinin önemli kısmını okulda geçirir.
- Bu yaşlarda kazanılan sağlık davranışları (beslenme, hareket, hijyen, sigara-alkolden uzak durma) **yaşam boyu sürer**.
- Görme, işitme bozuklukları, kansızlık, obezite, diş çürükleri, kronik hastalıklar ve ruhsal sorunlar okul başarısını doğrudan etkiler; erken saptanmaları önemlidir.
- Okul, kalabalık bir ortam olduğu için bulaşıcı hastalıkların yayılabileceği bir yerdir.
- Okul, **aileye ve topluma ulaşmanın köprüsüdür**: Öğrenciye verilen bilgi eve taşınır; velilere ve çalışanlara da okul aracılığıyla ulaşılır.

1.1 Okul sağlığı hemşiresinin rolleri

- **Bakım verici:** İlk yardım, kronik hastalığı olan öğrencinin okuldaki bakımı.
- **Eğitici:** Öğrencilere, öğretmenlere, velilere sağlık eğitimi.
- **Danışman:** Sağlık sorunu olan öğrenci ve ailelere danışmanlık.
- **Savunucu:** Öğrencinin sağlık haklarını ve sağlıklı okul ortamını savunma.
- **Koordinatör ve işbirlikçi:** Okul idaresi, rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri, aile, ASM, belediye ve diğer kurumlar arasında işbirliği.
- **Vaka yöneticisi:** Sorun saptanan öğrencinin yönlendirilmesi ve takibi.
- **Araştırmacı ve lider:** Okulun sağlık sorunlarını belirleme, program geliştirme.

1.2 Okul sağlığının bileşenleri

Günümüzde okul sağlığı, öğrenciyi merkeze alan **bütüncül bir model** olarak ele alınır (Bütüncül Okul, Bütüncül Toplum, Bütüncül Çocuk modeli). Bu modelin on bileşeni şunlardır:

1. **Sağlık eğitimi:** Sağlıklı yaşam bilgisi ve becerileri.
2. **Beden eğitimi ve fiziksel aktivite:** Ders içi ve ders dışı hareket olanakları.
3. **Beslenme ortamı ve hizmetleri:** Kantin, yemekhane, beslenme çantası, su erişimi.
4. **Sağlık hizmetleri:** Taramalar, ilk yardım, kronik hastalık yönetimi, aşı takibi.
5. **Danışmanlık, psikolojik ve sosyal hizmetler:** Rehberlik servisi.
6. **Sosyal ve duygusal iklim:** Zorbalıktan arınmış, güvenli, destekleyici okul ortamı.
7. **Fiziksel çevre:** Bina güvenliği, temizlik, aydınlatma, havalandırma, oyun alanları.
8. **Çalışanların sağlığı:** Öğretmen ve diğer personelin iyilik hali.
9. **Aile katılımı.**
10. **Toplum katılımı:** Belediye, sağlık kurumları, sivil toplum.

Okul sürecindeki çalışmalarını bu bileşenlere göre düşünmek, hiçbir alanı atlamamanı sağlar.

1.3 Türkiye'de okul sağlığıyla ilgili bazı uygulamalar

Okul sağlığı hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülür. Bilmen yararlı olan bazı uygulamalar:

- **Beyaz Bayrak:** Okulların temizlik ve hijyen standartlarını değerlendiren ve belgelendiren program.
- **Beslenme Dostu Okul:** Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi destekleyen okulların belgelendirilmesi.
- **Okulda Diyabet Programı:** Tip 1 diyabetli öğrencilerin okulda güvenle izlenmesi için öğretmen ve personelin eğitilmesi.
- **Okul kantinlerine yönelik düzenlemeler:** Enerji içecekleri, gazlı ve şekerli içecekler, yüksek tuz-yağ-şeker içeren atıştırmalıklar gibi sağlıksız ürünlerin satışını kısıtlayan düzenlemeler.
- ASM ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla yapılan okul **aşılamaları** (8. sınıfta Td) ve **taramalar**.

---

2. OKUL SÜRECİNİ NASIL YÜRÜTÜRSÜN? (GENEL AKIŞ)

1. **Hazırlık ve izinler:** Öğretim elemanı ve ilçe yetkilileri aracılığıyla okulla iletişim kurulur. Okul müdürüyle tanışılır, çalışmanın amacı, süresi ve yapılacak etkinlikler anlatılır. **Okul idaresinden izin** alınır; öğrencilerle yapılacak taramalar ve fotoğraflar için **veli bilgilendirmesi ve onamı** planlanır. Çalışmalar okul takvimine (sınav haftaları, etkinlikler) uygun planlanır.
2. **Okulu tanıma:** Okulun kademesi, öğrenci-öğretmen-personel sayıları, ikili ya da tam gün eğitim, taşımalı öğrenci olup olmadığı, kaynaştırma öğrencileri, fiziki yapı, çevresi öğrenilir.
3. **Risk değerlendirmesi:** Okulun fiziksel, sağlık ve psikososyal ortamı sistematik olarak değerlendirilir, riskler puanlanır ve önceliklendirilir.
4. **Gereksinimlerin belirlenmesi:** Risk değerlendirmesi, kayıtlar, taramalar, öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler sonucunda öğrencilerin ve çalışanların sağlık gereksinimleri belirlenir.
5. **Planlama:** Öğrencilere, çalışanlara ve velilere yönelik girişimler (taramalar, eğitimler, etkinlikler, okul idaresine öneriler) planlanır.
6. **Uygulama:** Taramalar, eğitimler, etkinlikler yapılır; kanıtlar (izinli fotoğraf, katılım listesi, materyal) toplanır.
7. **Değerlendirme:** Eğitimlerin etkisi (ön-son test), taramaların sonuçları, önerilerin uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilir.
8. **Raporlama:** Okul sağlığı raporu hazırlanır ve okul idaresiyle paylaşılır; Omaha kayıtları eklenir.

3. OKULUN RİSK DEĞERLENDİRMESİ (MADDE 15)

3.1 Risk değerlendirmesi nedir?

Risk değerlendirmesi, okulda var olan ya da dışarıdan gelebilecek **tehlikelerin belirlenmesi**, bu tehlikelerin **zarara dönüşme olasılığının ve zararın ciddiyetinin** değerlendirilmesi, risklerin **önceliklendirilmesi** ve **kontrol önlemlerinin** planlanması sürecidir.

- **Tehlike:** Zarar verme potansiyeli olan durum ya da etken (ıslak merdiven, sabunsuz lavabo, sabitlenmemiş dolap, okul önündeki trafik).
- **Risk:** Bu tehlikenin zarara dönüşme olasılığı ile zararın büyüklüğünün birleşimi.

Formdaki ifade "risk değerlendirmesini yapmak **ve buna uygun girişim planlamak**"tır; yani sadece tehlikeleri listelemek yetmez, her önemli risk için **ne yapılacağını, kimin yapacağını ve ne zamana kadar** yapılacağını da yazmalısın.

3.2 Risk değerlendirmesinin basamakları

1. **Veri toplama:** Okulun her bölümünü bir kontrol listesiyle **gezerek gözlemle**; okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri, hizmetli ve kantin görevlisiyle **görüş**; kayıtları **incele** (kaza ve revir defteri, devamsızlık nedenleri, kronik hastalığı olan öğrenci listesi, yangın tatbikatı kayıtları, su deposu temizlik kayıtları); gerekirse öğrenci ve çalışanlara kısa **anket** uygula; izinli **fotoğraf** çek (öğrenci yüzü görünmeden).
2. **Tehlikeleri belirleme:** Aşağıdaki alanlara göre.
3. **Riski puanlama:** Olasılık × şiddet.
4. **Önceliklendirme:** Yüksek riskler önce.
5. **Kontrol önlemlerini ve girişimleri planlama:** Kontrol hiyerarşisine göre; sorumlu ve süre belirterek.
6. **Raporlama ve paylaşma:** Okul idaresine yazılı rapor ve öneriler.
7. **İzlem:** Önerilerin uygulanıp uygulanmadığının kontrolü.

3.3 Değerlendirilecek alanlar – neye bakacağım?

Okulun çevresi:

- Okulun ana yola yakınlığı, trafik yoğunluğu; okul önünde **yaya geçidi, hız kesici, okul geçidi levhası, trafik görevlisi** olup olmadığı.
- Çevrede sanayi tesisi, gürültü, hava kirliliği kaynağı, çöplük, inşaat alanı, terk edilmiş yapılar.
- Okul çevresinde **tütün ve alkol satış noktaları**, oyun salonları.
- Başıboş hayvanlar.
- Okul servislerinin indirme-bindirme alanının güvenliği.

Bina ve bahçe:

- Duvar ve zeminde çatlak, dökülen sıva, kırık cam, tavandan su sızması, nem ve küf.
- **Merdivenler:** Kaydırmaz bant, tırabzan (korkuluk) yüksekliği ve sağlamlığı; korkuluk aralıkları çocuğun başının geçemeyeceği genişlikte mi? Merdiven boşluğundan düşme riski.
- Koridorlarda kaygan zemin; ıslak zemin uyarı levhası.
- **Bahçe:** Zemin düzgün mü, çukur ve taş var mı? Oyun alanı ekipmanları sağlam mı, keskin kenar var mı, altındaki zemin düşmeye karşı yumuşak mı? Bahçe kapısı ve duvarları güvenli mi? Gölgelik alan var mı?

Sınıflar:

- **Sınıf mevcudu** ve öğrenci başına düşen alan (kalabalık sınıf enfeksiyon yayılımını ve gürültüyü artırır).
- **Aydınlatma:** Yeterli doğal ışık; ışığın sağ elini kullanan öğrenciler için sol taraftan gelmesi; tahtada parlama olmaması; yeterli yapay aydınlatma.
- **Havalandırma:** Pencereler açılabiliyor mu, teneffüslerde sınıf havalandırılıyor mu?
- **Isı:** Sınıf ısısı yaklaşık 20–22 °C olmalıdır; aşırı sıcak ya da soğuk sınıf dikkati ve sağlığı etkiler.
- **Gürültü:** Dış gürültü ve sınıf içi gürültü düzeyi.
- **Sıra ve masalar:** Öğrencilerin boyuna uygun mu? Ayaklar yere basıyor mu, sırt destekli mi?
- **Elektrik güvenliği:** Açıkta kablo, kırık priz, priz yüksekliği (küçük sınıflarda koruyuculu priz).
- Keskin köşeli mobilyalar; **dolapların ve kitaplıkların duvara sabitlenmesi** (deprem riski).
- Sobalı sınıflarda karbonmonoksit zehirlenmesi ve yanık riski.

Tuvaletler ve lavabolar:

- Öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo; kız ve erkek tuvaletlerinin ayrı olması.
- **Temizlik**, koku, havalandırma.
- **Sabun, kâğıt havlu ya da kurutucu, akan su** (mümkünse ılık su) bulunup bulunmadığı – el hijyeninin en önemli koşulu.
- Kız tuvaletlerinde kapaklı çöp kovası (menstrüel hijyen), tuvalet kâğıdı.
- Kapı kilitleri, engelli tuvaleti.

Su:

- Şebeke suyu mu, depo mu? Su deposunun düzenli temizlenip temizlenmediği ve kayıtları.
- Öğrencilerin güvenli içme suyuna erişimi (sebil, şişe su).

Kantin ve yemekhane:

- Satılan ürünlerin sağlıklı beslenme ve mevzuata uygunluğu (şekerli-gazlı içecek, cips, enerji içeceği satışı var mı? Ayran, süt, meyve, tam tahıllı ürünler var mı?).
- Gıdaların saklanması, buzdolabı ısısı, son kullanma tarihleri.
- **Çalışanların hijyeni:** Bone, önlük, el yıkama, tırnaklar; **portör (periyodik sağlık) muayenelerinin ve hijyen eğitimi belgelerinin** olup olmadığı.
- Haşere kontrolü, bulaşık hijyeni.
- Yemekhanede menü; sebze-meyve yer alıyor mu?

Spor salonu ve laboratuvar:

- Spor salonunda zemin, ekipmanların sabitlenmesi (basketbol potaları, kale direkleri), ilk yardım malzemesi.
- Laboratuvarda kimyasalların güvenli saklanması, havalandırma, yangın söndürücü, göz duşu.

Yangın ve afet güvenliği:

- Yangın söndürücülerin varlığı, yerleri ve **dolum tarihleri**.
- **Acil çıkış** kapıları: işaretli mi, aydınlatılmış mı, dışa doğru açılıyor mu, kilitli mi ya da önü kapalı mı?
- **Tahliye planı** ve **tatbikat** (yangın, deprem) kayıtları; toplanma alanı.
- Deprem açısından sabitlenmemiş eşyalar.

İlk yardım ve sağlık hizmetleri:

- **İlk yardım dolabı ya da çantası:** Var mı, içeriği yeterli mi, malzemelerin son kullanma tarihleri geçmiş mi? Sorumlu kişi belli mi?
- Revir/sağlık odası.
- Okulda **ilk yardım sertifikası olan personel** var mı?
- Acil durum telefon listesi (112, ailelerin telefonları) görünür bir yerde mi?
- **Kaza kayıtları**.
- **Kronik hastalığı olan öğrencilerin listesi** ve her biri için bireysel sağlık planı (acil durumda ne yapılacağı) var mı?
- Okulda ilaç uygulama kuralları.

Psikososyal ortam:

- Akran zorbalığı, şiddet olayları, siber zorbalık.
- Rehberlik servisinin varlığı ve etkinliği.
- Madde kullanımı riski.
- Okula devamsızlık, okul terki.
- Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul iklimine ilişkin algısı.

Öğrenci sağlığı göstergeleri:

- Devamsızlık nedenleri (hangi hastalıklar sık?).
- Salgınlar: grip, ishal, el-ayak-ağız hastalığı, suçiçeği, pediküloz (bit), uyuz.
- Obezite, görme sorunu, diş çürüğü sıklığı (tarama sonuçlarından).
- Aşılanma durumu.

Erişilebilirlik: Rampa, asansör, engelli tuvaleti; kaynaştırma öğrencileri için düzenlemeler.

3.4 Riskin puanlanması (olasılık × şiddet)

Riskleri karşılaştırabilmek ve önceliklendirmek için her tehlike iki açıdan puanlanır:

Olasılık – Bu tehlike ne sıklıkla zarara dönüşebilir?

- **1 – Çok düşük:** Neredeyse hiç beklenmez.
- **2 – Düşük:** Nadiren olabilir.
- **3 – Orta:** Ara sıra olabilir.
- **4 – Yüksek:** Sık olabilir.
- **5 – Çok yüksek:** Neredeyse kesin; sürekli olabilir.

Şiddet – Zarar olursa ne kadar ciddi olur?

- **1 – Önemsiz:** İlk yardım bile gerektirmez.
- **2 – Hafif:** İlk yardım gerektirir.
- **3 – Orta:** Tıbbi tedavi gerektirir, kısa süreli okula devamsızlık.
- **4 – Ciddi:** Kalıcı hasar, uzun tedavi, hastaneye yatış.
- **5 – Çok ciddi:** Ölüm, çok sayıda kişinin yaralanması.

Risk skoru = Olasılık × Şiddet (1 ile 25 arasında).

- **1–6: Düşük risk** – Mevcut önlemler sürdürülür, izlenir.
- **8–12: Orta risk** – Belirli bir süre içinde planlı önlem alınır.
- **15–25: Yüksek risk** – **Hemen** önlem alınır; gerekirse o alanın kullanımı durdurulur.

Örnek puanlamalar:

- *Lavabolarda sabun ve kâğıt havlu yok:* Tüm öğrenciler her gün etkilenir, olasılık **5**; ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar, okul devamsızlığı olur, şiddet **3** → **15, yüksek risk.** Önlem: İdarenin hemen sabun ve kâğıt havlu sağlaması, öğrencilere el hijyeni eğitimi, haftalık kontrol.
- *Okul önünde yaya geçidi ve trafik levhası yok:* Olasılık **3**; trafik kazası ölüme yol açabilir, şiddet **5** → **15, yüksek risk.** Önlem: Belediyeye resmi yazı (idare), giriş-çıkış saatlerinde nöbetçi öğretmen ve veli gönüllüleri, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi.
- *Merdivenlerde kaydırmaz bant yok, temizlik sonrası zemin ıslak kalıyor:* Olasılık **4**; düşme kırığa yol açabilir, şiddet **3** → **12, orta risk.** Önlem: Kaydırmaz bant (müdür yardımcısı, 2 hafta içinde), temizliğin ders saatlerinde yapılması ve "ıslak zemin" levhası, teneffüslerde merdiven nöbeti.
- *İlk yardım çantasındaki malzemelerin süresi geçmiş:* Olasılık **3**, şiddet **3** → **9, orta risk.** Önlem: Malzemelerin yenilenmesi, sorumlu kişinin belirlenmesi, üç ayda bir kontrol.
- *Kantinde şekerli ve paketli ürün satışı:* Olasılık **4**, şiddet **2** → **8, orta risk.** Önlem: Kantin denetimi için idareye bildirim, sağlıklı ürün önerileri, öğrencilere beslenme eğitimi.
- *Kitaplıklar duvara sabitlenmemiş:* Olasılık **2**, şiddet **4** → **8, orta risk.** Önlem: Sabitleme (hizmetli, 1 ay içinde), deprem tatbikatı.

3.5 Kontrol önlemleri – hangi önlem daha etkili?

Önlemler, etkililik sırasına göre şu hiyerarşiyle düşünülür (en etkiliden en aza):

1. **Tehlikeyi ortadan kaldırma:** Kırık oyun aletini kaldırmak, sabitlenmemiş dolabı sabitlemek.
2. **İkame (daha az tehlikeli olanla değiştirme):** Tehlikeli kimyasal temizlik ürününü daha güvenli bir ürünle değiştirmek; sobayı kaloriferle değiştirmek.
3. **Mühendislik önlemleri:** Korkuluk yaptırmak, kaydırmaz bant, priz koruyucu, yaya geçidi ve hız kesici.
4. **İdari önlemler:** Nöbetçi öğretmen, kurallar, eğitim, uyarı levhaları, temizlik saatlerinin değiştirilmesi, tatbikat.
5. **Kişisel koruyucu donanım:** Temizlik personeli için eldiven, laboratuvarda gözlük.

Eğitim tek başına en zayıf önlemlerdendir; mümkünse tehlikeyi kaynağında ortadan kaldıran ya da azaltan önlemler önerilir ve eğitimle desteklenir.

3.6 Girişim planını yazmak

Her öncelikli risk için şu bilgiler yazılır: **tehlike – risk (ne olabilir) – kimler etkilenir – puan – önerilen önlem – sorumlu – süre – izlem.** Örnek bir yazım:

> **Tehlike:** Tuvalet lavabolarında sabun ve kâğıt havlu yok. **Risk:** Öğrenciler arasında ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarının yayılması. **Etkilenenler:** Tüm öğrenciler ve personel. **Puan:** 5 × 3 = 15 (yüksek). **Önlem:** Okul idaresinin tüm lavabolara sıvı sabunluk ve kâğıt havlu koyması (idare – hemen); hizmetli personelin günlük sabun kontrolü (idari önlem); tüm sınıflara el hijyeni eğitimi ve lavabolara yedi adımlık el yıkama posteri (öğrenci hemşire – 2 hafta içinde). **İzlem:** Bir hafta sonra lavaboların kontrolü ve teneffüs sonrası el yıkama gözlemi.

---

4. ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA YÖNELİK GİRİŞİMLER (MADDE 16)

4.1 Tarama öncesi hazırlık

- Okul idaresinin izni alınır; taramanın amacı ve yöntemi **velilere yazılı olarak bildirilir**, onam alınır.
- Taramanın yapılacağı yer hazırlanır: iyi aydınlatılmış, sessiz, **mahremiyeti sağlanmış** bir oda.
- Malzemeler hazırlanır: kalibre edilmiş tartı, boy ölçer, Snellen ya da E eşeli ve 6 metre mesafe işareti, göz kapatıcı, uygun boyutta çocuk manşonlu tansiyon aleti, ağız lambası ve tek kullanımlık abeslang, eldiven, ince dişli tarak, kayıt formu.
- Öğrencilere yapılacak işlem yaşlarına uygun bir dille anlatılır.
- Sonuçlar **gizlidir**: Sınıf önünde açıklanmaz, yalnızca veliye ve gerekli kişilere iletilir. Sorun saptanan öğrencinin velisine kapalı zarfta ya da bireysel görüşmeyle bilgi verilir ve **yönlendirme mektubu** verilir.

4.2 Okul taramaları – nasıl yapılır?

Boy, kilo ve BKİ taraması

- Öğrenci ayakkabısız ve hafif giysiyle tartılır; boyu duvara sabitlenmiş boy ölçerle, topukları, kalçası, kürek kemikleri ve başının arkası duvara değecek şekilde dik durarak ölçülür.
- BKİ (kg/m²) hesaplanır ve yaşa ve cinsiyete göre **persentil** eğrisinde değerlendirilir: **85. persentil ve üstü fazla kilolu, 95. persentil ve üstü obez**, 5. persentilin altı zayıf. Boyu yaşına göre 3. persentilin altındaysa büyüme geriliği açısından değerlendirilir.
- Obez ya da zayıf öğrencinin velisi bilgilendirilir ve ASM'ye yönlendirilir; öğrencinin damgalanmaması için kilo hakkında sınıfta konuşulmaz.

Görme taraması (Snellen eşeli)

- Eşel iyi aydınlatılmış bir duvara, öğrencinin göz hizasına asılır; öğrenci **6 metre (20 feet)** uzaklıktaki işaretin üzerinde durur ya da oturur.
- Okuma yazma bilmeyen ya da harfleri tanımayan küçük öğrencilerde **E eşeli** kullanılır (öğrenci E harfinin bacaklarının hangi yöne baktığını eliyle gösterir).
- Gözlüğü olan öğrenci **gözlüğüyle** test edilir.
- Önce **sağ göz**, sonra **sol göz** test edilir; test edilmeyen göz bir kapatıcıyla ya da avuç içiyle **bastırmadan** kapatılır (bastırmak sonraki testi bozar).
- Öğrenciden yukarıdan aşağıya doğru satırları okuması istenir; okuyabildiği en küçük satır o gözün görme keskinliğidir.
- **Yönlendirme:** Görme keskinliği yaşına göre beklenenin altındaysa (okul çağında genellikle 20/30 ya da 0,7'nin altı) ya da **iki göz arasında iki sıra ve daha fazla fark** varsa göz hekimine yönlendirilir. Ayrıca gözlerini kısan, başını eğerek bakan, sık göz ovuşturan, tahtayı göremediğini söyleyen, gözlerinde kayma olan öğrenciler de yönlendirilir.
- **Renk görme** Ishihara levhalarıyla değerlendirilebilir; renk körlüğü saptanan öğrenciye ve veliye bilgi verilir.

İşitme taraması

- Basit bir yöntem **fısıltı testidir**: Öğrenci bir kulağını parmağıyla kapatır; tarama yapan kişi öğrencinin arkasında ve yaklaşık bir kol boyu uzakta durarak (öğrenci dudak okuyamasın) sayı ya da sözcükleri fısıldar; öğrenci bunları tekrar eder. Diğer kulak için tekrarlanır. Varsa odyometre kullanılır.
- Ayrıca derste sık "Efendim?" diyen, söylenenleri tekrarlatan, dikkatsiz görünen, konuşma bozukluğu olan, sık kulak enfeksiyonu geçiren öğrenciler öğretmenlerden öğrenilir.

- Başarısız olan öğrenci kulak burun boğaz hekimine yönlendirilir.

Skolyoz taraması (Adams öne eğilme testi)

- Özellikle ergenliğin başında yapılır (kızlarda yaklaşık 10–12, erkeklerde 13–14 yaş).
- Öğrenci belden yukarısı açık (kızlarda atlet ya da sütyen ile), **aynı cinsiyetten bir eşlikçiyle**, mahremiyet sağlanarak muayene edilir.
- **Ayakta duruşta** arkadan bakılır: omuzlar ve kalçalar aynı seviyede mi, kürek kemikleri simetrik mi, kollar ile gövde arasındaki boşluklar eşit mi, omurga düz mü?
- Sonra öğrenci **ayakları bitişik, dizleri düz, kolları sarkık ve avuç içleri birleşik** olarak belden **öne eğilir**. Arkadan ve önden bakılır: Sırtın bir tarafında **kabarıklık (kaburga kamburluğu)** var mı?
- Asimetri saptanan öğrenci ortopedi hekimine yönlendirilir.

Ağız ve diş taraması

- Ağız lambası ve tek kullanımlık abeslang ile dişler ve diş etleri incelenir: çürük, dolgu, kayıp diş, diş taşı, diş eti kızarıklığı ve kanaması.
- Çürüğü olan öğrenci diş hekimine yönlendirilir. Altı yaş civarında çıkan ilk büyük azı dişlerine fissür örtücü önerilir.

Pediküloz (bit) taraması

- Saçlar özellikle **ense ve kulak arkasında** ince dişli bir tarak ya da iki abeslangla aralanarak incelenir.
- **Canlı bit** ya da saç köküne yakın (yaklaşık 1 cm içinde), saça sıkıca yapışık, tarakla kolay çıkmayan **sirkeler** (bit yumurtaları) aranır. Kepekten farkı: kepek kolayca düşer, sirke yapışıktır.
- Bit saptanan öğrencinin velisine **gizlilik içinde** bilgi verilir; öğrenci sınıf önünde teşhir edilmez ve damgalanmaz. Aileye tedavi anlatılır: hekim ya da eczacı önerisiyle bit şampuanı ve **7–10 gün sonra tekrar** uygulama; ıslak saçın ince dişli tarakla düzenli taranması; yastık kılıfı, çarşaf, havlu, şapkaların sıcak suyla yıkanması; **ailedeki herkesin kontrol edilmesi**; tarak, şapka, toka paylaşılmaması. Aynı sınıftaki ve kardeşlerdeki öğrenciler de kontrol edilir. Tedavi başlayan öğrenci okula devam edebilir.

Kan basıncı ölçümü

- Kol çevresine uygun **çocuk manşonu** ile, öğrenci 5 dakika dinlendikten sonra ölçülür. Sonuç yaş, cinsiyet ve boy persentiline göre değerlendirilir; yüksek bulunanlar tekrar ölçülür ve gerekirse ASM'ye yönlendirilir.

Aşı kartı kontrolü

- İlkokula başlayan öğrencilerde 48. ay aşılarının (KKK ve DaBT-İPA), 8. sınıfta Td aşısının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir; eksikler ASM'ye yönlendirilir.

Postür ve çanta ağırlığı

- Öğrencinin çantası tartılabilir; çanta ağırlığı **vücut ağırlığının yaklaşık %10–15'ini** geçmemeli, iki askılı olmalı ve iki omuzda taşınmalıdır.

4.3 Tarama sonrası

Tarama sonuçları sayısal olarak özetlenir (ör. "3–4. sınıflardan 112 öğrencinin görme taraması yapıldı; 14'ü (%12,5) göz hekimine yönlendirildi; 21 öğrenci (%18,8) fazla kilolu ya da obez bulundu"), bu sonuçlar **eğitim konularının seçiminde** kullanılır (obezite yüksekse beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi) ve okul idaresiyle paylaşılır. Yönlendirilen öğrencilerin hekime gidip gitmediği velilerle takip edilir.

4.4 Öğrencilere sağlık eğitimi ve etkinlikler

Sınıf düzeyine göre konu önerileri:

- **Okul öncesi ve ilkokul 1–2. sınıf:** El yıkama, diş fırçalama, sağlıklı beslenme (renkli tabak), su içme, güvenli oyun ve kazalardan korunma, trafik güvenliği, kişisel güvenlik ("vücudum bana ait").
- **İlkokul 3–4. sınıf:** Sağlıklı beslenme ve kahvaltı, fiziksel aktivite, ekran süresi, uyku, diş sağlığı, ilk yardımın temel kuralları, akran zorbalığı, güneşten korunma.
- **Ortaokul:** Ergenlik dönemi değişiklikleri (kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı), menstrüel hijyen, kişisel hijyen ve akne, sağlıklı beslenme ve obezite, beden imajı, sigara-elektronik sigara-alkolün zararları ve akran baskısına hayır deme, internet güvenliği ve siber zorbalık, ekran ve dijital denge, uyku.
- **Lise:** Madde kullanımı, ruh sağlığı ve stres-sınav kaygısı, sağlıklı ilişkiler, cinsel sağlık ve üreme sağlığı (okulun ve velilerin onayıyla, yaşa uygun), trafik güvenliği, ilk yardım, kanser farkındalığı (KKMM ve testis muayenesi), kan bağışı.

Etkinlik fikirleri (FR.186'da "sağlıkla ilgili bir etkinlik planlama"): El yıkama günü ve ultraviyole/boya ile "mikrop" deneyi; sınıflar arası diş fırçalama yarışması; sağlıklı beslenme tabağı hazırlama ya da afiş yarışması; su içme kampanyası; teneffüslerde hareketli oyunlar ya da dans; ekran yerine etkinlik haftası; akran zorbalığı drama çalışması; afet çantası hazırlama ve deprem tatbikatı; sağlık panosu hazırlama.

Her eğitim ve etkinlik için kısa bir **eğitim planı**, **materyal**, **katılımcı sayısı**, **değerlendirme** (ön-son test, soru-cevap, uygulama gözlemi) ve **izinli fotoğraf** hazırlanır.

4.5 Kronik hastalığı olan öğrencinin izlemi

Okuldaki kronik hastalığı olan öğrenciler idareden ve rehber öğretmenden öğrenilir. Her öğrenci için **bireysel sağlık planı** olup olmadığı kontrol edilir; yoksa aile ve okulla birlikte hazırlanması önerilir. Bireysel sağlık planı; tanıyı, kullandığı ilaçları, okulda dikkat edilecekleri, **acil durumda yapılacakları**, aile ve hekim iletişim bilgilerini içerir ve gizlilik çerçevesinde sınıf öğretmeni ve beden eğitimi öğretmeniyle paylaşılır.

Tip 1 diyabetli öğrenci:

- Öğretmen ve sınıf arkadaşları (öğrenci ve ailesinin izniyle) bilgilendirilir.
- **Hipoglisemi (düşük kan şekeri) belirtileri:** Terleme, titreme, solukluk, açlık, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, davranış değişikliği, bulanık görme; ağır durumda bilinç bulanıklığı ve nöbet.
- **Yapılacaklar:** Öğrenci bilinçliyse hemen **15 gram hızlı emilen şeker** (yarım bardak meyve suyu, 3–4 kesme şeker) verilir, 15 dakika sonra kan şekeri ölçülür, düşükse tekrarlanır; düzelince ara öğün verilir. **Bilinci kapalıysa ağızdan bir şey verilmez**, 112 aranır; eğitim almış personel varsa glukagon uygulanır.
- Öğrencinin sınıfta atıştırmalık yemesine ve su içmesine, tuvalete gitmesine izin verilir; kan şekeri ölçümü ve insülin uygulaması için uygun, temiz bir ortam sağlanır; beden eğitimi dersinden önce kan şekeri kontrolü ve yanında şeker bulundurması; sınav ve gezi günleri için plan.

Astımlı öğrenci:

- Tetikleyiciler (toz, polen, sigara dumanı, soğuk hava, egzersiz, güçlü kokular) sınıf ortamında azaltılır.
- Öğrencinin **kurtarıcı inhalerine** her an erişebilmesi sağlanır; beden eğitimi öncesi hekimin önerdiği şekilde inhaler kullanımı.
- **Astım atağı belirtileri:** Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma, konuşmakta güçlük. Öğrenci oturtulur, kurtarıcı inhaler kullanılır, sakinleştirilir; düzelmezse ya da dudaklar morarıyorsa 112.

Epilepsili öğrenci – nöbet sırasında ilk yardım:

- Sakin kal ve **nöbetin süresini tut**.
- Öğrencinin başını vurabileceği sert ve keskin cisimleri uzaklaştır, başının altına yumuşak bir şey koy, sıkan giysileri gevşet.
- **Ağzına hiçbir şey koyma**, dilini çekmeye çalışma; **kasılmaları tutmaya ya da durdurmaya çalışma.**
- Nöbet bittikten sonra öğrenciyi **yan yatır** (derlenme pozisyonu), solunumunu kontrol et, yanından ayrılma, uyumasına izin ver.
- **112'yi ara:** Nöbet **5 dakikadan uzun** sürerse, nöbetler arka arkaya gelirse, öğrenci kendine gelmezse, nöbet suda olduysa, yaralanma varsa ya da ilk kez nöbet geçiriyorsa.

Besin alerjisi ve anafilaksi riski olan öğrenci:

- Alerjen besin kantin, yemekhane ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşılan yiyeceklerde dikkatle kontrol edilir.
- **Anafilaksi belirtileri:** Dudak-dil-yüzde şişme, yaygın kaşıntılı döküntü, nefes darlığı, hırıltı, kusma, baş dönmesi, bayılma.
- Öğrencinin hekim tarafından reçete edilmiş **adrenalin oto-enjektörü** varsa, eğitimli personel tarafından **uyluğun dış yüzüne** uygulanır ve **112** aranır.

Çölyak hastası öğrenci: Glutensiz beslenme; kantin ve yemekhanede uygun seçenekler; okul etkinliklerindeki yiyecekler.

Kalp hastalığı olan öğrenci: Beden eğitimi derslerindeki kısıtlamalar hekim raporuna göre düzenlenir; acil durum planı.

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlüğü: Rehberlik servisiyle işbirliği; sınıfta ön sıraya oturtma, dikkat dağıtıcıları azaltma; ilaç saatleri.

Görme ve işitme kaybı olan öğrenci: Ön sıraya oturtma, materyallerin uygun hale getirilmesi.

4.6 Okulda bulaşıcı hastalıklar

Bulaşıcı hastalığı olan öğrencinin okuldan uzak kalma süresi konusunda il sağlık müdürlüğünün ve okulun talimatlarına uyulur. Genel olarak önerilen süreler şunlardır:

- **Suçiçeği:** Tüm döküntüler kabuklanana kadar (genellikle döküntü başladıktan yaklaşık 5 gün sonra).
- **Kızamık:** Döküntü başladıktan sonraki 4. güne kadar.
- **Kabakulak:** Tükürük bezlerindeki şişlik başladıktan 5 gün sonrasına kadar.
- **Kızamıkçık:** Döküntü başladıktan yaklaşık 5–7 gün sonrasına kadar.
- **Kızıl ve streptokok boğaz enfeksiyonu:** Uygun antibiyotik tedavisi başladıktan 24 saat sonrasına kadar.
- **Grip:** Ateş, ateş düşürücü kullanılmadan düştükten 24 saat sonrasına kadar.
- **İshal ve kusma (akut gastroenterit):** Son ishal ya da kusmadan 48 saat sonrasına kadar.
- **Hepatit A:** Sarılık ya da belirtiler başladıktan yaklaşık 7 gün sonrasına kadar.
- **Uyuz:** Tedavi başladıktan sonra (ertesi gün) okula dönebilir.
- **Pediküloz:** Tedavi başladıktan sonra okula devam edebilir; okuldan uzaklaştırma gerekmez.

Aynı sınıfta kısa sürede benzer belirtilerle çok sayıda öğrencinin hastalanması **salgın** şüphesidir ve **ASM'ye/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilir**.

---

5. OKUL ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER (MADDE 17)

5.1 Çalışanların sağlık riskleri

Öğretmenler:

- **Ses bozuklukları:** Sesin uzun süre ve yüksek sesle kullanılması ses kısıklığına, ses tellerinde nodüllere yol açabilir.
- **Uzun süre ayakta durma:** Varis, bacak ağrısı.
- **Kas-iskelet sorunları:** Bel ve boyun ağrısı (tahtaya yazma, kâğıt okuma, ağır çanta taşıma).
- **Stres ve tükenmişlik:** Kalabalık sınıflar, iş yükü, veli ve öğrenci ilişkileri.
- **Enfeksiyonlar:** Öğrencilerden bulaşan solunum yolu ve diğer enfeksiyonlar.
- İdarecilerde ve öğretmenlerde **hareketsiz yaşam**, kronik hastalıklar.

Temizlik personeli:

- **Kimyasal maruziyet:** Cilt ve solunum yolu tahrişi. En önemli uyarı: **Çamaşır suyu ile tuz ruhu ya da asitli temizlik ürünlerinin karıştırılması zehirli klor gazı açığa çıkarır**; bu, ciddi solunum sorunlarına ve ölüme yol açabilir.
- **Kas-iskelet sorunları:** Kova taşıma, eğilme, yük kaldırma.
- **Kayma-düşme**, kesici atıklarla yaralanma.

Kantin ve yemekhane çalışanları:

- Gıda kaynaklı hastalıkları öğrencilere bulaştırma riski; bu nedenle **portör muayeneleri** ve **hijyen eğitimi** önemlidir.
- Yanık, kesik, sıcak ortamda çalışma.

Servis şoförleri ve güvenlik görevlileri: Hareketsiz yaşam, stres, uyku-yorgunluk, trafik kazası; şoförlerde görme ve kan basıncı önemlidir.

5.2 Çalışanlara yönelik taramalar ve kronik hastalık izlemi

- **Kan basıncı ölçümü**, **parmak ucu kan şekeri**, **boy-kilo-BKİ-bel çevresi**.
- **Sigara kullanımı** sorgulanır; bırakmak isteyenler ALO 171'e ve sigara bırakma polikliniğine yönlendirilir.
- Yaşa uygun **kanser taramaları** sorgulanır (30–65 yaş kadın HPV, 40–69 yaş kadın mamografi, 50–70 yaş kolorektal) ve eksikler yönlendirilir.
- **Aşı durumu:** Td, risk grubundaysa grip aşısı.
- **Kronik hastalığı olan çalışanlar** (hipertansiyon, diyabet, astım) ilaç kullanımı ve kontrolleri açısından sorgulanır, kontrol dışı değerleri olanlar ASM'ye yönlendirilir.
- Sonuçlar **kişiye özel** olarak bildirilir; öğretmenler odasında yüksek sesle açıklanmaz.

5.3 Çalışanlara yönelik eğitim konuları

- **Ses sağlığı:** Gün boyu bol su içme; bağırmadan sınıfı sessizleştirme teknikleri (el işareti, ses tonu değişimi, bekleme); kalabalık sınıflarda mikrofon; sigara ve aşırı kafeinden kaçınma; ses kısıklığı üç haftadan uzun sürerse KBB'ye başvurma.
- **Stres yönetimi ve tükenmişlik:** Stres belirtileri, gevşeme ve nefes egzersizleri (uygulamalı), zaman yönetimi, iş-yaşam dengesi, sosyal destek, gerektiğinde profesyonel yardım.
- **Ergonomi ve bel-boyun sağlığı:** Doğru oturma ve ayakta durma, doğru yük kaldırma, mola ve germe egzersizleri; varis için bacak egzersizleri ve rahat ayakkabı.
- **Kronik hastalıklar:** Hipertansiyon ve diyabet; doğru kan basıncı ölçümü; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite.

- **Kanser taramaları.**
- **Okulda ilk yardım:** Nöbet, hipoglisemi, astım atağı, anafilaksi, yaralanma, burun kanaması, boğulma (Heimlich manevrası) durumlarında yapılacaklar.
- **Temizlik personeline:** Kimyasalların asla karıştırılmaması, orijinal ve etiketli kabında saklanması, eldiven ve maske kullanımı, havalandırma, doğru kaldırma tekniği.
- **Kantin çalışanlarına:** El hijyeni, bone-önlük, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrılması, gıdaların uygun ısıda saklanması.

---

6. EĞİTİMİN UYGULANMASI: VELİ VE ÇALIŞANLARLA İLETİŞİM (MADDE 18)

Formdaki 18. madde eğitimin içeriğinden çok **organizasyonunu ve değerlendirmesini** puanlar: iletişimin kurulması, zaman ve sürenin belirlenmesi, materyalin etkin kullanılması ve eğitimin değerlendirilmesi.

1. İzin ve işbirliği: Eğitim konusu ve planı okul müdürüyle ve **rehber öğretmenle** paylaşılır; onları sürece katmak hem katılımı artırır hem de eğitimin okulda sürdürülmesini sağlar.

2. Hedef kitleye ulaşma ve davet:

- **Veliler için:** Okul idaresi aracılığıyla yazılı davet; sınıf öğretmenlerinin veli iletişim grupları üzerinden duyuru; öğrenciler aracılığıyla eve gönderilen davet kartı; **veli toplantısı** gününe denk getirme.
- **Öğretmenler için:** Öğretmenler kurulu ya da zümre toplantısı, öğle arası ya da ders bitiminde kısa oturum; öğretmenler odasına duyuru.
- **Diğer personel için:** Çalışma saatlerine uygun, işlerini aksatmayacak bir zaman.

3. Zaman ve süre: Yetişkin gruplar için genellikle **20–30 dakika** eğitim ve ardından soru-cevap uygundur. Zaman, katılımcıların en uygun olduğu saat olarak seçilir (veliler için okul çıkışı ya da akşam veli toplantısı; öğretmenler için ders sonrası).

4. Ortam ve materyal: Uygun bir sınıf ya da salon, oturma düzeni (mümkünse yüz yüze bakabilecekleri düzen), projeksiyon ya da kartlar, maket, broşür hazırlanır. Materyal **etkin** kullanılmalıdır: yalnızca slayt okumak yerine maket üzerinde gösterim, katılımcılara uygulatma, gerçek örnek (5 gram tuzu kaşıkta göstermek, içeceklerdeki şekeri küp şekerle göstermek, el yıkamayı uygulatmak).

5. Eğitimin akışı: Kendini tanıtma ve dikkat çekme; konunun önemi ve hedefler; ana mesajlar (3–5 mesaj); uygulama ya da etkileşim; özet ve soru-cevap; kaynak ve broşür dağıtımı.

6. Eğitimin değerlendirilmesi: Eğitim öncesi ve sonrası aynı 4–5 soruluk kısa test (ön test–son test); soru-cevap; uygulamalı becerilerde geri gösterim; katılımcıların kısa geri bildirim formu (eğitimi yararlı buldular mı, ne öğrendiler, neyi uygulayacaklar); mümkünse sonraki haftalarda davranış izlemi (el yıkama gözlemi, kantin satışları).

7. Kayıt ve kanıt: Katılımcı listesi ya da sayısı, eğitim planı, materyal, **izinli fotoğraf** (yüzler görünmeden), ön-son test sonuçları, Omaha kaydı.

Veli eğitimi için konu önerileri: Çocukta sağlıklı beslenme ve obezite, beslenme çantası; ekran süresi ve dijital güvenlik; uyku düzeni; akran zorbalığını fark etme; ergenlik döneminde iletişim; pedikülozla mücadele; aşılar; ev kazaları ve ilk yardım; ağız-diş sağlığı.

---

7. OKULDA OMAHA KULLANIMI (MADDE 19)

Okul eğitimleri de Omaha sistemiyle kaydedilir. Okulda dikkat edilecek nokta **kapsam niteleyicisidir**:

- Bir **sınıfa**, **öğretmen grubuna** ya da **veli grubuna** verilen eğitim → **Toplum**.
- Tek bir öğrenciye ya da öğretmene yönelik girişim (ör. diyabetli öğrencinin izlemi) → **Birey**.
- Bir öğrencinin ailesiyle birlikte çalışılıyorsa → **Aile**.

Okulda sık kullanılan problemler:

- Risk değerlendirmesinden çıkan sorunlar için: **Sanitasyon** (sabun yok, tuvaletler kirli), **Komşuluk/işyeri güvenliği** (trafik, bahçe ve bina tehlikeleri).
- Öğrenciler için: **Bulaşıcı/enfeksiyöz durum** (el hijyeni, pediküloz, salgın), **Ağız sağlığı**, **Görme**, **İşitme**, **Beslenme**, **Fiziksel aktivite**, **Uyku ve dinlenme örüntüleri**, **Kişisel bakım**, **Büyüme ve gelişme**, **Kişilerarası ilişki** (akran zorbalığı), **Madde kullanımı**, **Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu** (skolyoz, postür).
- Çalışanlar için: **Ruh sağlığı** (stres), **Konuşma ve dil** (ses kısıklığı), **Ağrı** (bel-boyun ağrısı), **Dolaşım** (yüksek tansiyon), **Sağlık bakımı denetimi** (kanser taraması).

Örnek – 3. sınıfa diş sağlığı eğitimi:

- **Problem:** Fizyolojik – **Ağız sağlığı** – Toplum (3-A sınıfı, 26 öğrenci) – Gerçek. Belirti: Taramada 26 öğrencinin 11'inde çürük; öğrencilerin çoğu gece diş fırçalamadığını söyledi.
- **Girişimler:** Sağlık eğitimi – *Kişisel hijyen* (günde iki kez, iki dakika diş fırçalama, florürlü macun, doğru teknik diş maketi üzerinde gösterildi ve uygulatıldı); Sağlık eğitimi – *Diyet yönetimi* (şekerli ve yapışkan yiyeceklerin azaltılması); Vaka yönetimi – *Tıbbi/dental bakım* (çürüğü olan 11 öğrencinin velilerine yönlendirme mektubu); Gözetim – *Kişisel hijyen* (bir ay sonra diş fırçalama takvimi kontrolü).
- **Değerlendirme (grup):** Bilgi 2 → 4 · Davranış 2 → 3 · Durum 3 → 3 (çürükler tedaviyle değişecek; yönlendirmeler takip edilecek).

---

8. OKUL SAĞLIĞI SÜRECİ RAPORU NASIL HAZIRLANIR?

Okul sürecinin sonunda hazırlayacağın raporun bölümleri:

1. **Okulun tanıtımı:** Okulun adı (kodlanabilir), kademesi, öğrenci-öğretmen-personel sayıları, eğitim düzeni, fiziki yapısı ve çevresi.
2. **Veri toplama yöntemleri:** Gözlem (kontrol listesi), görüşmeler (kimlerle), kayıt incelemesi, anketler, taramalar ve tarihleri.
3. **Risk değerlendirmesi:** Alanlara göre saptanan tehlikeler; her önemli tehlikenin olasılık-şiddet puanı ve risk düzeyi; öncelikli riskler.
4. **Öğrencilere yönelik girişimler:** Taramalar ve sonuçları (sayı ve yüzde ile), yönlendirmeler; eğitimler ve etkinlikler (konu, sınıf, katılımcı sayısı, değerlendirme sonucu); kronik hastalığı olan öğrencilere yönelik çalışmalar.
5. **Çalışanlara yönelik girişimler:** Taramalar, saptanan riskler, eğitimler.
6. **Veli eğitimleri:** Konu, katılımcı sayısı, değerlendirme.
7. **Eğitim planları** ve ön-son test sonuçları.
8. **Omaha kayıtları.**
9. **Okul idaresine öneriler:** Her öneri için sorumlu ve süre.
10. **Sonuç** ve **ekler** (kontrol listesi, anket formu, broşürler, izinli fotoğraflar).

---

9. KENDİNİ TEST ET

1. Okul sağlığı neden önemlidir? Okul sağlığı hemşiresinin rollerini say.
2. Bütüncül okul sağlığı modelinin on bileşeni nelerdir?
3. Okul risk değerlendirmesinin basamaklarını sırala.
4. Risk değerlendirmesinde hangi alanlara bakarsın? Her alandan üç örnek ver.
5. Olasılık ve şiddet puanları neyi ifade eder? Risk skoru 15 ne anlama gelir, ne yapılır?
6. Kontrol önlemleri hiyerarşisini sırala. Neden eğitim tek başına zayıf bir önlemdir?
7. "Lavabolarda sabun yok" tehlikesi için risk puanlaması ve girişim planı yaz.
8. Okulda tarama yapmadan önce neler yaparsın?
9. Snellen testi nasıl yapılır? Hangi durumlarda göz hekimine yönlendirirsin?
10. Adams öne eğilme testinde neye bakarsın?
11. Pedikülozlu öğrenci saptadığında ne yaparsın?
12. Tip 1 diyabetli öğrenci derste titriyor ve terliyor. Ne yaparsın?
13. Sınıfta nöbet geçiren öğrenciye ilk yardım nasıl yapılır? Hangi durumlarda 112 aranır?
14. Suçiçeği, kızamık, grip ve ishalde öğrenci okula ne zaman döner?
15. Öğretmenlerin ve temizlik personelinin sağlık riskleri nelerdir? Temizlik personeline mutlaka hangi uyarıyı yaparsın?
16. Velilere yönelik bir eğitimi nasıl organize edersin? Değerlendirmeyi nasıl yaparsın?
17. Okulda Omaha kaydında kapsam niteleyicisini nasıl seçersin? Bir sınıf eğitimi için örnek Omaha kaydı yaz.